

EDUARDO MASSASHI IKEDA

MEDICAMENTOS:

SINTOMAS/QUEIXAS

HAS

BANHEIRO

não

HORA QUE ACORDA

6:30

HORA QUE DORME

22:30 - 23h.

PRÁTICA EXERCÍCIO

2ª 4ª e 6ª (2ª e 5ª caminhada).

HORARIO DAS REFEIÇÕES

CAFE:

ALMOÇO:

LANCHE:

JANTA:

13/09 P = 9.1 / cmH<sub>2</sub>O

22 IAH = 2.1 / ev

Fuoga = 14.4

m. de uso: 6h20'

Relata melhora no cansaço.

fua

20/09 P = 8.7

22 m. de uso: 5h36'

IAH = 2.6 / ev

fua

08/11 P = 8.6

22 IAH = 2.0

m. de uso: 5h14'

Bem adaptado s/ queixas, oriento fua

fua

12/12 P = 8.6 cmH<sub>2</sub>O

22 IAH = 1.7 e / ev

m. de uso: 5h35'

cansaço zero.

fua

13/02 P = 8.6 cmH<sub>2</sub>O

23 IAH = 1.2 e / ev

m. de uso: 5h9'

fua

P = 8.6 cmH<sub>2</sub>O

IAH = 1.0

Nome: EDUARDO MASSASHI IKEDA

Data de Nascimento: 6-6-1970

IMC: 27,10

Sexo: Masculino

Data do exame: 01-08-2022

Peso: 83 kg

Altura: 1,75 m

Médico: DR. JEFFERSON KIYOSHI

TAKEHARA

Medicamentos:

Histórico:

### Laudo de Polissonografia

Exame realizado na noite de 01-08-2022, sendo feita avaliação simultânea de eletroencefalograma, eletrooculograma, eletromiograma (região submentoniana e músculo tibial anterior), posição corporal, ronco, fluxo aéreo nasal e oral, esforço respiratório torácico e abdominal, saturação arterial de oxigênio (SpO2) e eletrocardiograma. Os resultados encontram-se em anexo.

O tempo total de registro foi de 481,5. As latências de estágio N1 e sono de REM foram, respectivamente, 64,0 e 216,0 minutos. O tempo total de sono foi de 292,0, eficiência de 60,6% (normal > 85%) e as porcentagens das fases de sono em relação ao tempo total de sono foram: estágio N1: 3,8%; estágio N2: 62,5%; estágio N3: 11,6%; sono REM: 22,1%. O índice de despertares foi de 23,7/hora (normal < 10/h).

O índice de apneia/hipopneia total foi de 46,6/hora, sendo elas 46 obstrutivas, 0 mistas e 0 centrais e 56 hipopnéias. A SpO2 média foi de 93% e mínima de 72%, permanecendo 9,9% do tempo de registro com a saturação abaixo de 90%. A frequência cardíaca no estágio REM oscilou entre 59 - 94 bpm e NREM de 61 - 98 bpm.

**CONCLUSÃO:** Os dados do registro polissonográfico, associados aos do Questionário de Sono e escala de Epworth (10), favorecem as seguintes hipóteses diagnósticas:

1. Polissonografia demonstrando eficiência do sono reduzida;
2. porcentagem do estágio N3 do sono NREM diminuída e porcentagem do estágio N2 do sono NREM aumentada;
3. índice de apnéia + hipopnéia (IAH) de 46,6/hora;
4. houve dessaturação da oxihemoglobina (min. SaO2=72%);
5. latências para o sono prolongadas;
6. aumento do número de despertares breves;
7. presença de atividade em EMG de queixo;
8. presença de movimentos periódicos de membros inferiores (2,7/hora);
9. registro de ronco moderado durante o sono.

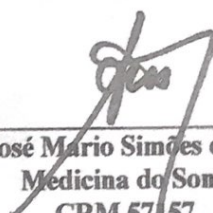
**Exame evidenciando apneia obstrutiva do sono de grau acentuado. Presença de bruxismo.**

IAH: 05-15 /hora leve.

IAH: 15-30 /hora moderada.

IAH: > 30 /hora acentuada.

Nota: O diagnóstico depende da correlação conjunta com outros fatores.

  
Dr. José Mario Simões da Costa  
Medicina do Sono  
CRM 57157